



ENTRE HORMÔNIOS E RECOMEÇOS

Informações **essenciais** para **viver a
menopausa** com **saúde, prazer e
segurança**

SUMÁRIO



1. **CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO**
2. **CAPÍTULO 2 – O QUE É A MENOPAUSA**
3. **CAPÍTULO 3 – RISCOS E BENEFÍCIOS DA TERAPIA HORMONAL**
4. **CAPÍTULO 4 – CÂNCER DE MAMA E TERAPIA HORMONAL**
5. **CAPÍTULO 5 – ALTERNATIVAS NÃO HORMONAIS PARA OS SINTOMAS DA MENOPAUSA**
6. **CAPÍTULO 6 – SEXUALIDADE NA MENOPAUSA: REDESCOBERTA, CUIDADOS E ORIENTAÇÕES**
7. **CAPÍTULO 7 – MENOPAUSA SEM TABU**
8. **CAPÍTULO BÔNUS – LIBERDADE, AUTOCONHECIMENTO E NOVOS COMEÇOS**
9. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**
10. **REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS**





UM CUIDADO QUE VAI ALÉM DA CONSULTA

Sou a **Dra. Veruska Barijan**, médica formada pela Unicamp e **especialista em saúde da mulher**.

Preparei este **e-book** para compartilhar **informações seguras e práticas** que ajudam **mulheres** a viver a **menopausa** com mais **saúde, prazer e confiança**.

Cada **página** é uma **extensão** do meu **trabalho no consultório** — um **espaço** para se **sentir amparada e fortalecida** em cada **escolha**.



01

INTRODUÇÃO

A **menopausa** é uma fase **natural** da vida da **mulher**, marcada pelo **encerramento** do **ciclo reprodutivo** e pela **queda** da produção dos **hormônios ovarianos**, especialmente o **estrogênio**. Apesar de ser um **processo biológico** esperado, a **menopausa** ainda é cercada de **dúvidas, inseguranças** e, muitas vezes, **desinformação**.

Com o avanço da **medicina**, hoje sabemos que é **possível** atravessar essa etapa com **saúde, bem-estar e qualidade de vida**. No entanto, para isso, é **fundamental** que a **mulher** tenha acesso a **informações** claras, embasadas em **evidências científicas** e apresentadas com **empatia**.

Entre os **temas** que mais geram dúvidas está o uso da **terapia hormonal** e sua relação com doenças como o **câncer de mama**.

Neste **e-book**, vamos abordar esse **assunto** de forma **responsável e acolhedora**, desmistificando **medos**, esclarecendo **benefícios e riscos**, e mostrando que a **decisão** sobre o tratamento deve ser sempre **individualizada**.

Aqui, você **encontrará** também **orientações** sobre **alternativas não hormonais, sexualidade na menopausa** e dicas **práticas** para **cuidar de si mesma** nesse **novo momento**.



02

O QUE É A MENOPAUSA?

A **menopausa** é definida como a **última menstruação** da mulher, confirmada após **12 meses** consecutivos **sem menstruar**. Esse evento marca o **fim da fase reprodutiva** e ocorre, em média, entre os **45 e 55 anos**.

No entanto, os **sintomas** e as **mudanças hormonais** costumam começar antes desse marco, na fase chamada **climatério**.

SINTOMAS DO CLIMATÉRIO

- Ondas de calor (fogachos)
- Suores noturnos
- Insônia
- Irritabilidade ou alterações de humor
- Diminuição da libido
- Ressecamento vaginal
- Irregularidade menstrual
- Cansaço e falta de energia

Durante o **climatério**, nessa fase de transição, os **ovários** reduzem **gradualmente** a produção de **estrogênio e progesterona**. Esse **desequilíbrio hormonal** pode provocar uma variedade de **sintomas**, que variam de mulher para **mulher**

MENOPAUSA NATURAL

VS

MENOPAUSA INDUZIDA

Ocorre espontaneamente com o envelhecimento.

Resultado de cirurgia (remoção dos ovários), quimioterapia ou radioterapia, levando à interrupção abrupta da produção hormonal.



DIAGNÓSTICO E EXAMES:

Na maioria dos casos, o **diagnóstico da menopausa é clínico**, baseado na **ausência de menstruação** e nos sintomas relatados. **Exames hormonais**, como FSH (hormônio folículo-estimulante), podem ser **solicitados** em situações específicas, especialmente em **mulheres mais jovens** ou com história de **ciclos irregulares**.

MENOPAUSA NÃO É DOENÇA:

É importante reforçar que a **menopausa não é uma patologia**, mas sim uma **fase da vida**. No entanto, os **sintomas** podem ser **intensos** e impactar **significativamente** a **qualidade de vida**. Nesses casos, tratamentos **individualizados** podem **ajudar** – e a **terapia hormonal** é uma das **opções**, como veremos a seguir.



03

RISCOS E BENEFÍCIOS DA TERAPIA HORMONAL

A **Terapia Hormonal (TH)** consiste na administração de **hormônios** — geralmente **estrogênio isolado** ou **estrogênio combinado à progesterona** — com o objetivo de **aliviar os sintomas** da **menopausa** e **prevenir** algumas das **alterações** decorrentes da **deficiência hormonal**.

PARA QUE SERVE A TERAPIA HORMONAL?

A **TH** é indicada **principalmente** para o **alívio de sintomas moderados a intensos** da **menopausa** como:

- Ondas de calor (fogachos)
- Sudorese noturna
- Insônia
- Irritabilidade
- Secura vaginal e dor nas relações
- Diminuição da libido
- Queda da massa óssea (osteopenia/osteoporose)





ESTROGÊNIO ISOLADO X COMBINADO

A escolha do tipo de terapia depende da presença ou não do útero:

- **Estrogênio combinado à progesterona:** necessário para mulheres com útero, pois a progesterona protege o endométrio dos efeitos proliferativos do estrogênio.
- **Estrogênio isolado:** indicado apenas para mulheres que fizeram histerectomia (remoção do útero), pois o uso de estrogênio sem progesterona em mulheres com útero pode aumentar o risco de câncer de endométrio.

RISCOS E BENEFÍCIOS DA TERAPIA HORMONAL



QUEM PODE SE BENEFICIAR?

Mulheres saudáveis, antes dos 60 anos ou com até 10 anos desde a última menstruação (momento conhecido como janela de oportunidade), costumam ter maior benefício e menor risco com a terapia hormonal.

OS BENEFÍCIOS INCLUEM:

- Melhora significativa da qualidade de vida;
- Redução dos sintomas vasomotores;
- Proteção contra perda óssea;
- Melhora da lubrificação e da função sexual;
- Possível melhora da saúde cardiovascular (dependendo do perfil da paciente);
- Benefícios cognitivos: estudos sugerem que, quando iniciada na janela adequada, a TH pode ter um efeito protetor sobre funções cognitivas, como memória e atenção, ajudando a prevenir ou retardar o declínio cognitivo relacionado à idade.

E QUAIS OS RISCOS DA TH?

A avaliação dos riscos deve ser individualizada. Entre os principais pontos de atenção:

- **Câncer de mama:** o uso de TH combinada (estrogênio + progesterona) por mais de 5 anos pode aumentar discretamente o risco — esse tema será abordado com mais profundidade no próximo capítulo.
- **Trombose venosa profunda:** risco pequeno, mas maior em mulheres com predisposição genética, histórico familiar ou obesidade. As formas transdérmicas (adesivos ou gel) têm menor impacto nesse sentido.
- **Doença cardiovascular:** o início tardio da terapia (mais de 10 anos após a menopausa) pode aumentar o risco em algumas mulheres. Por isso, a janela de oportunidade é um conceito fundamental.

A TH É SEGURA?

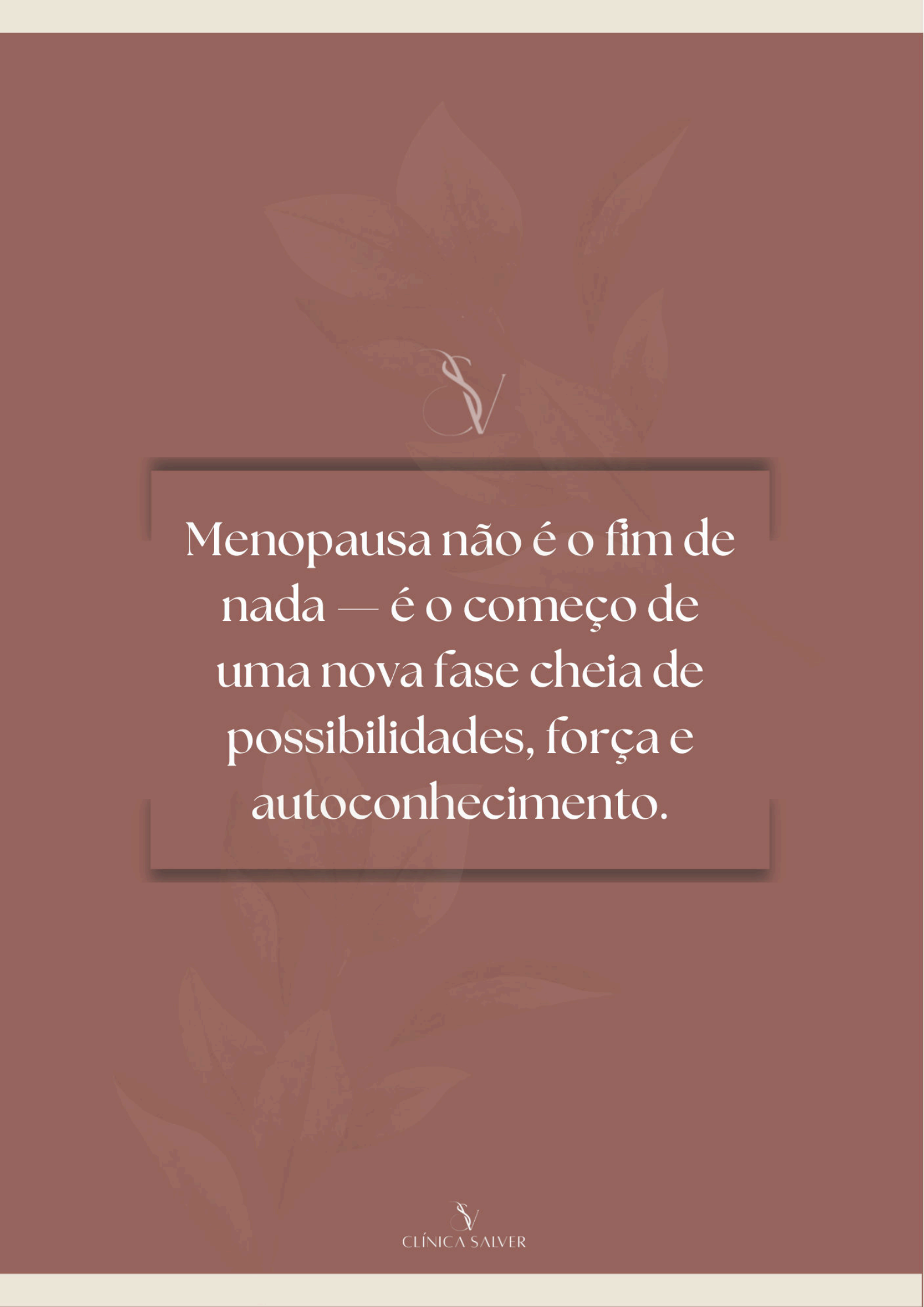
Sim — quando bem indicada, bem acompanhada e utilizada dentro do tempo recomendado, a TH é considerada segura e eficaz. O acompanhamento médico deve ser contínuo, com reavaliações periódicas.

INDIVIDUALIZAÇÃO É A CHAVE

Não existe uma única resposta para todas. A escolha da terapia, da dose e da via de administração (oral, transdérmica, vaginal) deve considerar:

- Idade da mulher
- Tempo de menopausa
- Presença de útero
- Histórico familiar e pessoal
- Preferência da paciente





Menopausa não é o fim de
nada — é o começo de
uma nova fase cheia de
possibilidades, força e
autoconhecimento.

04



TERAPIA HORMONAL E CÂNCER DE MAMA: O QUE VOCÊ PRECISA SABER

AFINAL, A TH CAUSA CÂNCER DE MAMA?

Não é tão simples assim. O que os **estudos mostram** é que **alguns tipos de terapia hormonal** aumentam discretamente **o risco de câncer de mama** – mas isso depende **do tipo de hormônio, do tempo de uso** e de **cada mulher**.

O QUE DIZEM OS GRANDES ESTUDOS?

WHI – Women's Health Initiative (maior estudo até hoje que acompanhou mais de 160.000 mulheres nos Estados Unidos) mostrou que **mulheres que usaram estrogênio + progesterona** (por mais de 5 anos) **tiveram 8 casos a mais de câncer de mama a cada 10.000 mulheres por ano**, a incidência foi de **30 para 38 mulheres**. Já quem usou somente **estrogênio** (pacientes sem útero) teve **redução no risco, 4 casos a menos**.

QUANDO A TH É INDICADA MESMO COM ESSE RISCO?

- Quando os sintomas da **menopausa** (ondas de calor, insônia, secura vaginal, alterações de humor) **afetam** muito a **qualidade de vida**.
- Em mulheres com **baixo risco** pessoal **de câncer de mama** (sem histórico familiar relevante ou alterações genéticas).
- Quando **usada por tempo limitado** e com reavaliação anual.

MENSAGEM DA SUA MÉDICA



O **risco de câncer de mama** com **terapia hormonal existe**, mas é **pequeno e controlável**. A decisão de **usar ou não** deve ser **feita com cuidado**, baseada nos seus **sintomas** e no seu **histórico pessoal**. Na grande **maioria dos casos**, os **benefícios superam os riscos**, especialmente quando **a TH é bem indicada**, na janela de **oportunidade** e de perto, com **exames de controle periódicos**.



05

ALTERNATIVAS NÃO HORMONAIAS PARA OS SINTOMAS DA MENOPAUSA



Nem todas **as mulheres** podem ou desejam fazer uso da **terapia hormonal (TH)**. Seja por contraindicações, histórico familiar, receio ou preferência pessoal, **existem alternativas seguras e eficazes para aliviar os sintomas da menopausa** — especialmente **os fogachos, distúrbios do sono e alterações de humor**.



1. NOVOS TRATAMENTOS NÃO HORMONAIS: FEZOLINETANTE



O **fezolinetante** é uma **medicação** de uma **nova** classe chamada antagonista do receptor de neurocinina-3 (NK3R). Ele atua **diretamente** no centro **termorregulador** do **hipotálamo**, **reduzindo** os **fogachos sem interferência hormonal**.

- Já **aprovado** pela FDA (EUA) para o tratamento de fogachos moderados a intensos.
- Ainda **não está disponível no Brasil**, mas representa uma **opção promissora** para o futuro, devendo chegar por **aqui em breve**.



2. ANTIDEPRESSIVOS COM EFEITO NOS FOGACHOS

Certos **antidepressivos**, mesmo em **doses menores** que as usadas para depressão, **demonstraram eficácia** na **redução dos sintomas vasomotores**:

- **ISRS (como paroxetina, escitalopram)**
- **IRSN (como venlafaxina, desvenlafaxina)**

São **especialmente úteis** para **mulheres** que têm **contraindicação ao uso de hormônios** ou que apresentam **sintomas leves a moderados**, além de ajudarem em casos de **depressão** ou **ansiedade associadas**.



3. TERAPIAS COMPLEMENTARES E MENTE-CORPO

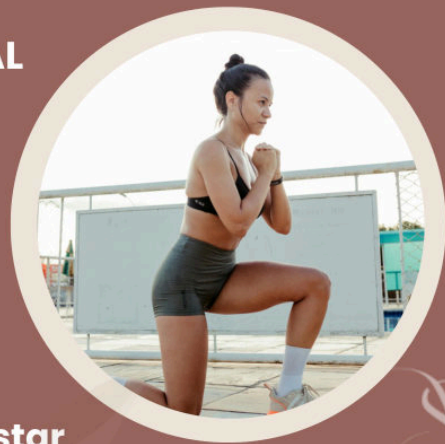
- **Terapia cognitivo-comportamental (TCC)**: melhora da **insônia**, **ansiedade** e percepção dos **fogachos**.
- **Mindfulness e meditação**: favorecem equilíbrio emocional.
- **Acupuntura**: pode ajudar individualmente, com resultados variáveis.



4. ESTILO DE VIDA COMO ESTRATÉGIA CENTRAL

- **Atividade física** regular;
- **Alimentação** equilibrada;
- **Boa higiene** do sono;
- Evitar **tabagismo e álcool**

Esses **pilares** são **fundamentais** para o **bem-estar** geral no **climatério**.



5. TRATAMENTOS PARA OS SINTOMAS GENITURINÁRIOS

A **síndrome geniturinária da menopausa (SGM)** inclui sintomas como:

- **Secura vaginal**;
- **Dor** na relação (dispareunia);
- **Infecções urinárias** de repetição;
- **Urgência** urinária

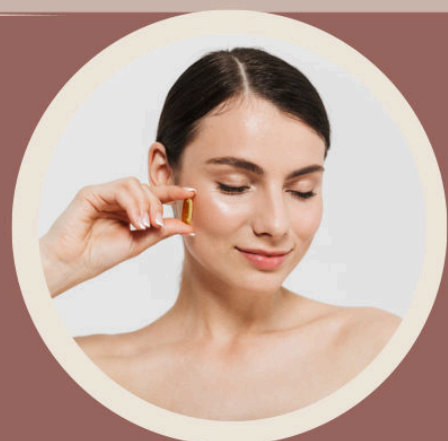


As **opções** disponíveis incluem:

- **Estrogênio vaginal** em baixas doses: com **excelente segurança** e mínimo risco sistêmico.
- **Laser vaginal e FRAXX** (radiofrequência): **tecnologias** que promovem renovação do tecido vaginal, melhora da lubrificação, elasticidade e vascularização local. São **boas opções** para mulheres que não desejam ou não podem usar **hormônios**.

6. SUPLEMENTAÇÃO DIRECIONADA

- **Vitamina D e cálcio**: ossos e imunidade
- **Ômega 3**: saúde cardiovascular e mental
- **Magnésio e vitaminas do complexo B**: energia e humor



06



SEXUALIDADE NA MENOPAUSA: REDESCOBERTA, CUIDADOS E ORIENTAÇÕES

A **menopausa** marca uma **transição fisiológica** importante, mas **não representa o fim da vida sexual** — pelo contrário, pode ser um momento de **renovação da intimidade, autoconhecimento** e conexão **emocional**.

Ainda assim, é **comum** que **muitas mulheres** enfrentem **desafios** nesse período, seja por **alterações hormonais, emocionais** ou **mesmo culturais**. Falar sobre **sexualidade** de forma **aberta** e **acolhedora** é parte **fundamental do cuidado** com a **saúde feminina**.



CLÍNICA SALVER



1. AS PRINCIPAIS QUEIXAS

Entre os **sintomas** mais **frequentes** estão:

- Diminuição da libido e da excitação;
- Dor nas relações sexuais (dispareunia);
- Ressecamento e diminuição da lubrificação vaginal;
- Dificuldade para atingir o orgasmo.

2. ASPECTOS EMOCIONAIS E RELACIONAIS

A **sexualidade** vai **muito além** da **biologia**. Questões como **autoestima**, **imagem corporal**, **segurança emocional** e **qualidade do relacionamento** têm forte **impacto**.

A **menopausa** pode coincidir com outras **mudanças na vida** (filhos saindo de casa, aposentadoria, luto, mudanças profissionais), o que pode **influenciar** o **desejo** e a **disposição**.

Conversas francas com a **parceria** são **essenciais** e, quando **necessário**, o **apoio** de **psicólogos** ou **terapeutas sexuais** pode ser **transformador**.





3. ESTRATÉGIAS PARA MELHORAR A VIDA SEXUAL NA MENOPAUSA

- Lubrificantes e hidratantes vaginais são aliados importantes no alívio do ressecamento. Dilatadores vaginais, quando indicados, auxiliam na recuperação da elasticidade e no alívio da dor.
- Terapia hormonal local (vaginal): o uso de estrogênio vaginal em doses baixas melhora significativamente a lubrificação e a elasticidade da mucosa vaginal.
- Entre as terapias tecnológicas, o Laser vaginal tem ganhado cada vez mais evidência. Trata-se de uma técnica não cirúrgica e indolor que estimula a regeneração do colágeno e a promove a restauração da mucosa vaginal. É especialmente eficaz no tratamento da atrofia genital e da secura vaginal, comuns na pós-menopausa, além de auxiliar em casos leves de incontinência urinária. O procedimento melhora a elasticidade, vascularização e hidratação dos tecidos, resultando em mais conforto durante as relações sexuais.
- Atividade física: aumenta a circulação, energia e autoconfiança.
- Exploração do próprio corpo: se conhecer é fundamental para ter prazer.
- Criar intimidade fora do quarto: carinho, presença, conexão emocional.
- Leituras sensuais e contos eróticos: podem ajudar a despertar o desejo, estimular a imaginação e favorecer a excitação seja sozinha ou com parceria. Estimular a mente é tão importante quanto estimular o corpo.





Além disso, é **essencial** manter uma **conversa franca** com a **parceria** — especialmente em **relacionamentos de longa data**. Falar sobre **expectativas, desejos e mudanças** fortalece o vínculo, contribuindo para a **retomada da intimidade** e abrindo espaço para uma **vivência sexual** mais plena. A **comunicação aberta**, a **paciência** e o **respeito mútuo** são **pilares** para redescobrir **o prazer** nessa **fase da vida**.



4. A LIBIDO PODE VOLTAR?

Sim — e muitas vezes **com mais intensidade, segurança e liberdade**. Sem o **medo** de **engravidar** e com mais **autoconhecimento**, muitas mulheres **redescobrem o prazer** de forma **mais livre**. A **libido não desaparece**: ela pode estar **adormecida por um tempo**, mas com **cuidado e atenção**, pode ser **plenamente retomada**.

5. QUANDO PROCURAR AJUDA?

Se a **sexualidade** estiver **causando dor, frustração** ou **insegurança**, procure **apoio especializado**. **Ginecologistas** com foco na **saúde da mulher** na **menopausa** podem orientar com **empatia** e **individualização**.



A menopausa marca o fim
do ciclo reprodutivo, mas
não o fim da feminilidade,
da sexualidade ou do
prazer



07



MENOPAUSA SEM TABU: LIBERDADE, AUTOCONHECIMENTO E NOVOS COMEÇOS

A **menopausa** marca o **fim do ciclo reprodutivo**, mas **não o fim da feminilidade**, da **sexualidade** ou do **prazer**. Pelo contrário — para **muitas mulheres**, é o início de uma **fase de liberdade, reconexão** com o **próprio corpo** e com as **escolhas pessoais**.





1. A QUEBRA DE UM TABU

Durante **anos**, a **menopausa** foi retratada como um **declínio**: da **juventude**, da **sexualidade**, da **beleza**. Hoje, sabemos que ela é apenas uma **transição**, como **tantas outras** que vivemos ao **longo da vida**.

Ao falar **abertamente** sobre o tema, **derrubamos barreiras** que o **silêncio** impôs e abrimos **espaço** para mais **saúde**, mais **empatia** e mais **autonomia**.

3. LIBERDADE PARA FAZER NOVAS ESCOLHAS

Com os **filhos crescidos**, a **carreira** mais **estável** ou a **vida** mais **serena**, muitas **mulheres** se redescobrem na **menopausa**. É o momento de dizer **“sim”** ao que faz sentido e **“não”** ao que já **não cabe**.

A **liberdade** de decidir o que **vestir**, como se **cuidar**, com quem se **relacionar** e como **viver sua sexualidade** é uma conquista **preciosa**.



2. O PODER DO AUTOCONHECIMENTO

A **menopausa** convida ao **olhar para dentro**: para o **corpo**, para os **desejos**, para os **limites**.

Entender as **mudanças**, nomear os **sintomas**, reconhecer o que é **natural** e o que pode ser tratado são **atos de cuidado** consigo **mesma**.

É uma **oportunidade** de **ajustar rotas** e redefinir **prioridades** com mais **clareza** e **maturidade**.

4. A BELEZA DO RECOMEÇO

Há **beleza** no **amadurecimento**, na **leveza** de quem já não precisa **provar** nada a ninguém, na **sabedoria** construída com o **tempo**.

A **menopausa** pode ser o **recomeço** de uma vida mais **autêntica**, conectada com quem você é de **verdade** — e isso merece ser **celebrado**.

08

CAPÍTULO BÔNUS

CUIDAR DE SI É UM ATO DE CORAGEM E CONHECIMENTO

Por Dra. Veruska Barijan – Ginecologista

Falar sobre **menopausa** é falar sobre um **recomeço**. Não um fim, como **tantas vezes** escutamos — mas um **novo ciclo** que pode ser **vivido** com **saúde, prazer e autonomia**.

Acredito que a **informação** verdadeira, **acessível** e sem julgamentos é uma das **maiores ferramentas** que uma **mulher** pode ter.

É por isso que este **e-book** nasceu: para **acolher dúvidas**, desfazer **mitos** e oferecer **caminhos possíveis** — sempre com respeito às **individualidades** e à **ciência**.

Nos **últimos anos**, vimos um **avanço** importante no **estudo** da **terapia hormonal**, entendendo **melhor seus riscos** e, principalmente, seus **benefícios** quando **bem indicada**.

A **medicina** que praticamos **hoje não** se resume a **números** — ela olha para a **mulher inteira**: seu **histórico**, sua **rotina**, seus **medos**, seus **desejos**.

É nesse **contexto** que a **decisão** de **usar** ou **não hormônios** deve ser feita: **juntas**, em **diálogo**, com **responsabilidade** e **confiança**.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que este **material** tenha sido um **guia gentil** e **confiável**, ajudando a **iluminar caminhos**, trazer **segurança** nas escolhas e mostrar que a **menopausa** pode ser **vivida** com **leveza** e **conhecimento**.

Mais do que **desfazer mitos**, nosso **desejo** é **fortalecer** sua **autonomia** com **base** na **ciência** e no **cuidado**.

Com carinho,

Dra. Veruska Barijan
Ginecologista – Clínica Salver

Dr. Bruno Salvador S. Lima
Mastologista – Clínica Salver



REFERÊNCIAS CIENTÍFICAS



1. The Women's Health Initiative (WHI)

- Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. JAMA. 2002;288(3):321–333.
- Manson JE, Chlebowski RT, Stefanick ML, et al. Menopausal hormone therapy and health outcomes during the intervention and extended poststopping phases of the Women's Health Initiative randomized trials. JAMA. 2013;310(13):1353–1368.

2. North American Menopause Society (NAMS)

- The 2022 Hormone Therapy Position Statement of The North American Menopause Society. Menopause. 2022;29(7):767–794.
- Disponível em: <https://www.menopause.org>

3. International Menopause Society (IMS)

- Baber RJ, et al. 2016 IMS Recommendations on women's midlife health and menopause hormone therapy. Climacteric. 2016;19(2):109–150.

4. Sociedade Brasileira de Climatério (Sobrac)

- Diretrizes brasileiras para terapia hormonal da menopausa. Atualizações recentes em parceria com outras sociedades médicas.

5. Breast Cancer Risk Assessment Tools

- Gail Model (National Cancer Institute). Disponível em: <https://bcrisktool.cancer.gov>

6. Colaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer

- Type and timing of menopausal hormone therapy and breast cancer risk: individual participant meta-analysis of the worldwide epidemiological evidence. Lancet. 2019;394(10204):1159–1168.

7. NICE Guidelines (UK)

- Menopause: diagnosis and management. NICE guideline [NG23]. Atualizado em 2023.
- Disponível em: <https://www.nice.org.uk/guidance/ng23>

8. Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM)

- Protocolos clínicos sobre risco mamário, seguimento e segurança na prescrição de TH.



Este material é de autoria exclusiva da Clínica Salver. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo por quaisquer meios, sem a autorização prévia e expressa da clínica. Este e-book tem finalidade exclusivamente informativa e não substitui orientações profissionais personalizadas.